

Ceratite

Conceito

A ceratite ou ceratite infecciosa refere-se à invasão microbiana da córnea, causando inflamação e dano ao epitélio, estroma ou endotélio da córnea.

Obs.: pode ser infecciosa ou não infecciosa, mas a última é, na maioria das vezes, rara.

Principal causa de cegueira no mundo

Etiologias

→ Microbiana

- Bactérias;(MAIS COMUM)
 - Progressão rápida
 - Estafilococos coagulase negativos;
 - S.Aureus;
 - Streptococcus pneumoniae;
 - Pseudomonas aeruginosa;
- Fungos;
- Parasitas.
 - Ceratite viral
- Vírus da Herpes;

Bacteriana

Fatores de Risco

- Uso de lentes de contato;
- Uso de esteróides tópicos;
- Doença da superfície ocular;
- Trauma ocular;
- Ceratite prévia;
- Cirurgia prévia;
- DM;

Características Clínicas:

- Sintomas: visão turva, vermelhidão fotofobia;
- Sinais:
 - Hipópio:



-
- Cocos gram-positivos:
 - Ulceração corneana localizada;
 - Infiltrados estromais acinzentados;
 - Bordas distintas;
 - Mínima opacidade estromal circundante;
- Bacilos gram-negativos:
 - Surpuração estromal densa;
 - Curso rápido;
 - Córnea circundante opaca, anel imune

Diagnóstico

- Coloração de gram: sensibilidade de 60-75%
- Cultura: Sensibilidade: 38%–66%
- PCR: Sensibilidade: 25%–88%

Tratamento

- Monoterapia com fluoroquinolonas
OU
- Antibióticos fortificados: Cefazolina 5% mais gentamicina 0,9%
- Considere o uso adjuvante de corticoide tópico após pelo menos 2 a 3 dias de melhora quando:
 - O organismo foi identificado e o infiltrado corneano compromete o eixo visual.

Por herpes simples

- Herpes simplex tipo 1;
- Incubação: 1-28 dias (contato direto com lesões infectadas ou secreções)

Fatores de Risco

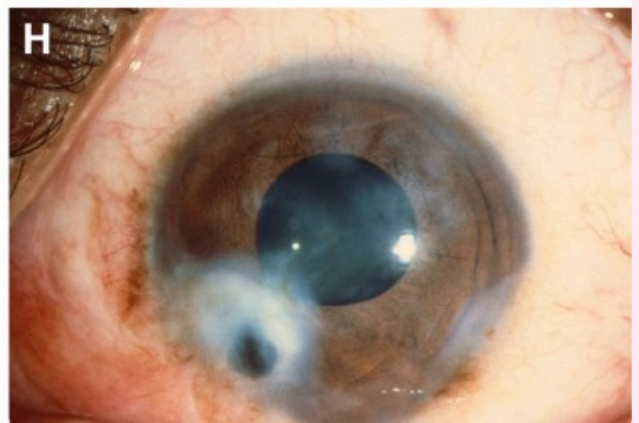
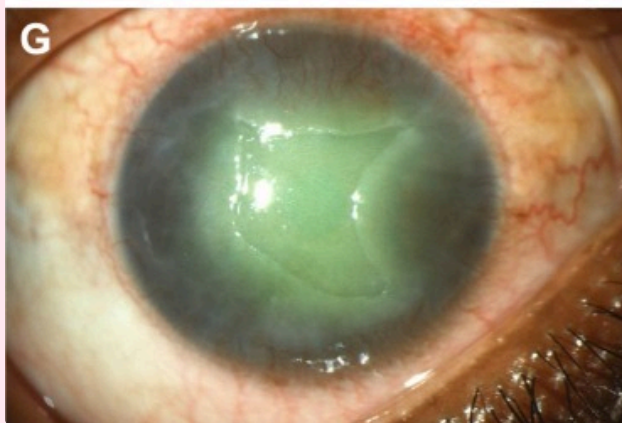
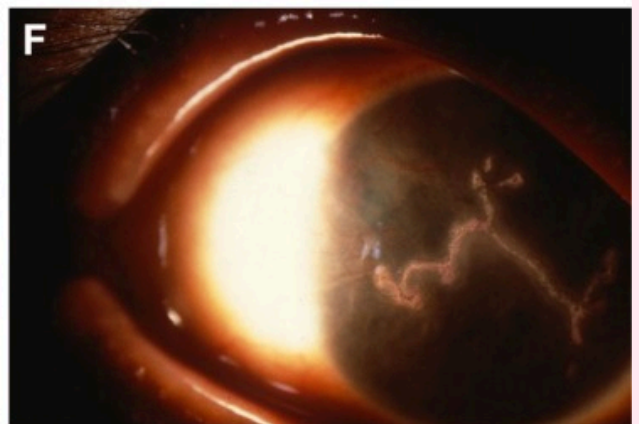
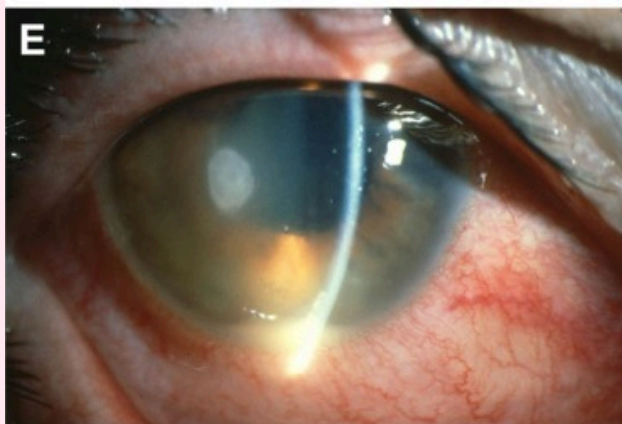
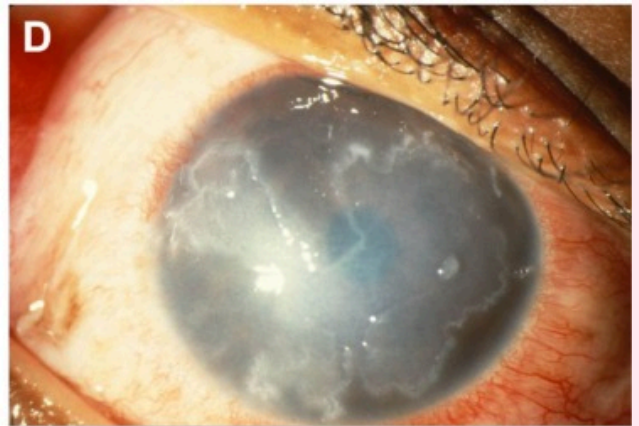
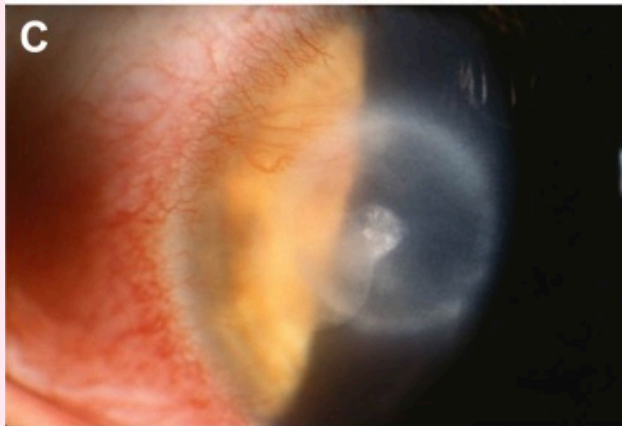
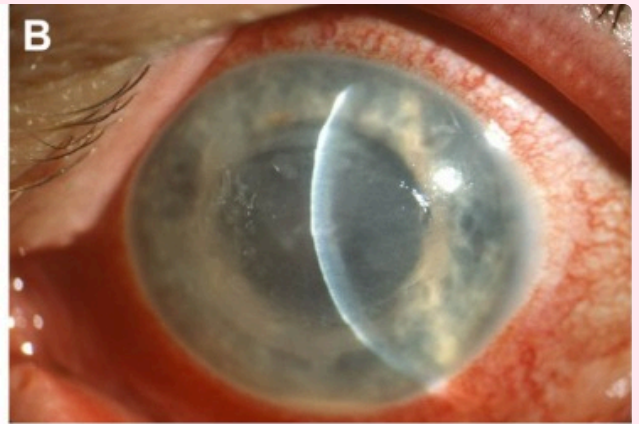
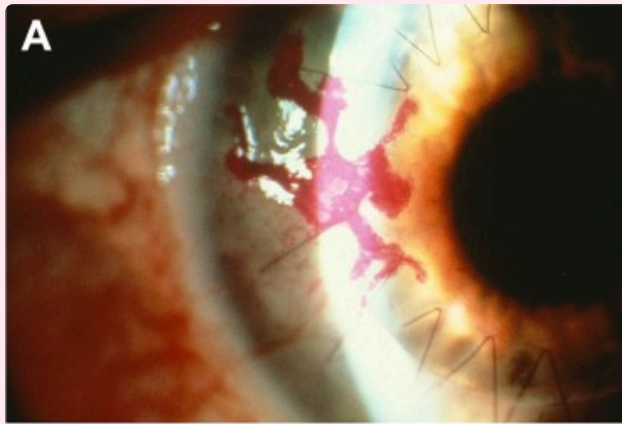
- Imunossupressão;
- Extremos de idade;
- DM;

- Sarampo;
- Uso de colírios com agonistas de prostaglandinas;
- Histórico recente de herpes;

Classificação

- Epitelial:
 - Úlceras geográficas de córnea com cauda dendrítica ou ceratite dendrítica;
- Estromal:
 - Disciforme
 - Imune
 - Necrosante
- Endotelial: precipitados ceráticos em forma de linhas de rejeição e edema estromal

- Ceratouveíte



Diagnóstico

- **PCR** :
 - Sensibilidade: 70%–100%
 - Especificidade: 67,9%–98%

Tratamento

- **HSK epitelial :**
Occ ACV 3% cinco vezes ao dia durante 1 a 2 semanas OU
VLC 500 mg BD, 7 dias
- **HSK estromal sem ulceração :**
VLC 500 mg uma vez ao dia durante o uso de corticoide tópico MAIS Prednefrin Forte 4 a 6 vezes ao dia, com redução gradual da dose ao longo de >10 semanas
- **HSK estromal com ulceração :**
VLC 1 g TDS por 7 a 10 dias
Além disso, a dose de Prednefrin Forte, duas vezes ao dia, é reduzida gradualmente à medida que a doença entra em controle.
- **HSK endotelial :**
VLC 500 mg uma vez ao dia a 1 g três vezes ao dia durante 7 a 10 dias
(Não há evidências clínicas suficientes para orientar a dosagem nesta situação) MAIS Prednefrin Forte 4 a 6 vezes ao dia, com redução gradual da dose ao longo de >10 semanas
- **Ceratouveíte**
VLC 1 g TDS por 7 a 10 dias
MAIS Prednefrin Forte 4 a 6 vezes ao dia, com redução gradual da dose ao longo de >10 semanas
- **Profilaxia**
ACV 400 mg BD OU
VLC 500 mg uma vez ao dia

Fúngica

Etiologias

- **Fungos filamentosos :**
Fusarium spp . e *Aspergillus spp* .
- **Leveduras :** *Candida spp* .

Características clínicas

- **Sintomas :** Vermelhidão, lacrimejamento, dor, sensibilidade à luz, secreção, diminuição da visão.
- **Sinais :**
 - *Fungos filamentosos* : tecido descamado seco e elevado, infiltrado estromal com margens hifais, lesões satélites e exsudato endotelial espesso.
 - *Candida spp* .: ceratite estromal semelhante à ceratite bacteriana, defeito epitelial sobrejacente, infiltrado discreto, progressão lenta, localização inferocentral

“Tá.. Socorro- Preciso saber de tudo isso como generalista? Nem de oftalmo eu gosto”

KKKK não, não- Na prática pro não especialista o importante é identificar a ceratite e entender o nível de gravidade. Para dar o seguimento correto do paciente.

Então, não esqueça, suspeitou de ceratite:

1. Encaminhar *o mais rápido possível*
2. Tirar lente de contato (se presente);
3. Fluoresceína (se tiver);
 - Identificar lesões de córnea precocemente;
4. Alta suspeita de acometimento bacteriano + Demora no encaminhamento
 - Colírio ATB de amplo espectro
 - Moxifloxacino 0,5% colírio
 - Dose Inicial: 1 gota a cada uma hora nas primeiras 24h e após isso (se melhora), reduzir para intervalo de 2-4h.
 - Ciprofloxacino 0,3% (mesma posologia);
 - Obs: se houver identificação de úlcera grande/central/grave, a evolução for muito rápida ou o pct for imunossuprimido, optar por ATB's como vancomicina + ceftazidima;
 - 🖐 considere **grave** se tiver:
 - ≥ 2 mm de diâmetro
 - **central** (eixo visual)
 - infiltrado denso
 - bordas mal definidas
 - hipópio
 - progressão rápida
 - Vancomicina 25-50 mg/ml (gram +);
 - Ceftazidima 50 mg/ml (gram -| Cobre pseudomonas);
Posologia: 1 gota de cada **alternando a cada 30 minutos**(ou seja, colírio a cada 15 min intercalado). Manter nas primeiras 24h → Depois: espaçar conforme resposta
5. Analgesia
 - Sistêmica (primeira linha)
 - Dipirona

- Ibuprofeno
- Ciclopégico (se dor com fotofobia)
 - Ciclopentolato 1%: 1 gota de 2-3 vezes ao dia;
👉 Por quê?
 - reduz espasmo do músculo ciliar
 - melhora dor e fotofobia

⚠️ **O que não fazer**

1. Não fazer corticóides em quadros agudos;
2. Ocluir olho